



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هاله ابراهيم ابراهيم محمد

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : خمسة عشر مايو العنوان : مجاورة 11 - حى ط - عمارة 2

رقم البطاقة : 26707240101526 رقم التليفون : 01147344939 تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026 العمر (تاريخ الميلاد) : 24-07-1967 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
المقر بما فيه
التوقيع: (-----) (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاله ابراهيم ابراهيم محمد National ID: 26707240101526	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

أ.د. ناجح عبد الوهاب

أستاذ الأشعة - جامعة القاهرة

تاريخ الفحص : 9/5/2026
كود المريض : 659919
رقم العملية : 11260506018
Thank you for referring this case,

هاله ابراهيم ابراهيم
59

الاسم :
السن :
جهة التحويل :
الطبيب المعالج أ.د.:

مصطفى محمود ابو العلا

High Resolution Breast Ultrasound Examination Of Both Breasts Revealed:

- **Left breast:** showing two neighboring spiculated suspicious hypoechoic solid lesions seen at 11-12 o'clock away from nipple by distance of 6cm showing posterior acoustic shadowing & peripheral vascularity seen measuring 9x10mm & 29x34mm respectively
- No evidence of internal cystic degeneration seen.
- Otherwise Normal parenchymal echogenicity and thickness and glandular distribution
- No solid mass No cystic lesions in Rt breast.
- Normal nipple areola complexes.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour
- Bilateral non specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast suspicious mass lesions for both Mammography correlation & histopathological assessment (BIRADs IVb)
- Normal sonographic examination of Rt breast (BIRADS I)

Nashwa Elsayed Hamed.MSc

Name: هاله ابراهيم ابراهيم محمد		
MR. : 11326		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 59-year-old individual with a history of hysterectomy performed 20 years ago, four offspring, and a post-menopausal status. There is no personal history of diabetes mellitus or hypertension and no known family history of cancer. The initial presentation was left breast pain; imaging revealed a BIRADS 5 left breast mass measuring 2.6 × 2 cm with solitary axillary lymph node involvement. Core biopsy confirmed invasive ductal carcinoma, grade 3, clinical stage T2 N1. Hormone receptor testing showed estrogen receptor 3/8 (10 %) and progesterone receptor 3/8 (10 %). HER2 was 3+ and Ki-67 was 70 %. Staging work-up included bone scan, CT of the chest/abdomen/pelvis, and adrenal imaging suggestive of bilateral adrenal hyperplasia. Echocardiogram demonstrated a left ventricular ejection fraction of 65 %. The multidisciplinary team (MDT) recommended neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen followed by surgery. The MDT plan included placement of surgical clips prior to neoadjuvant therapy with TCHP for six cycles, with subsequent assessment of response to determine suitability for breast-conserving surgery. The patient received the first cycle of TCHP today, and baseline echocardiography confirmed an ejection fraction of 65 %. During the first cycle, the patient developed grade 2 diarrhea and vomiting. Laboratory evaluation revealed a total leukocyte count of $2 \times 10^9/L$, a creatinine of 1.6 mg/dL (up from 1.2 mg/dL), and other findings consistent with treatment-related toxicity, prompting supportive measures. The patient has a past medical history of hypertension and hypothyroidism. Post-neoadjuvant assessment shows left-sided breast cancer now classified as clinical T2 N0 (post-clip insertion). After completing cycle 1 of TCHP, the patient experienced grade 2 diarrhea. For cycle 2, the regimen was adjusted to include Taxotere 120 mg, Carboplatin AUC 5 (maximum dose 500 mg), and Phesgo, with prophylactic Neupogen administered. On examination, a residual left breast mass measured 2 × 2 cm, and echocardiography again showed an ejection fraction of 65 %. The patient has now completed two cycles of the TCHP regimen.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	20-09-2026 التاريخ :
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		